سياقات عمل الرعاية الصحية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة
(الربو والامراض التنفسية الانسدادية المزمنة)

اختيار المراجعين المشمولين بفحص وظائف الرئة (من قبل الطبيب)

- التأكد من عدم وجود موانع اجراء الفحص. (مرفق باللغة الانكليزية).
- أي مراجع بعمر **خمس سنوات فأكثر** يعاني من أعراض تنفسية سفلى متكررة (recurrent lower respiratory tract symptoms) وحسب ما ورد في استمارة الرعاية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة .
- المراجع **المشخص** مسبقاً بالإصابة بالربو او COPD.
- يستثنى من ذلك الأطفال دون سن الخامسة والحوامل .

اولا :- المراكز التي يتوفر فيها جهاز سبايروميتر و جهاز PEFM

<u>الوحدة الطبية</u> (الطبيب)

- يتم تحديد المشمولين من قبل الطبيب وحسب ما ورد في استمارة الرعاية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة
- تملأ الحقول من قبل الطبيب عدا تسلسل الاستمارة.
- التاكد من عدم وجود موانع لاجراء الفحص.
- يحال الى مشغل جهاز السبايروميتر مع الاستمارة.
- قراءة **وتوثيق نتائج الفحص الاولي** في الاستمارة وتحديد الحاجة الى موسع القصبات (التبخير بجهاز النبيولايزر واجراء الفحص (بعد ١٥ دقيقة من انتهاء التبخير) .
- توثيق نتائج الفحص (بعد اعطاء الموسع) في الاستمارة.
- تحديد التشخيص النهائي وحسب نتيجة فحص وظائف الرئة.
- الايعاز الى المنسق لفتح ملف المريض (الملف هو نفس الملف الطبي للأمراض غير الانتقالية او ملف صحة الاسرة وتضاف وتكبس الاوراق الخاصة بالرعاية الاولية للربو). (Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ Asthma) واكمال الحقول

او الاوراق الخاصة بالرعاية الاولية لمرض **COPD.**

(Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ COPD) واكمال الحقول.

- توثيق الاجراءات وحسب دلائل المعالجة.
- اجراء فحوصات المتابعة عن طريق جهاز PEFM .
- تسليم الملفات والاستمارات الى المنسق نهاية الدوام.
- الاحالة حسب دلائل العمل.
- تسليم خطة المتابعة الذاتية لمريض الربو وتدريب المريض على استخدامها .
- التأشير في استمارة الرعاية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة .

مشغل الجهاز سبايروميتر :

هو احد الملاكات الصحية المدرب على تشغيل جهاز السبايروميتر.

- توثيق المعلومات الديموغرافية وتاريخ المراجعة والقياسات الجسمانية في الاستمارة وسجل الجهاز.
- يتم اعطاء تسلسل الاستمارة حسب سجل جهاز السبايروميتر.
- اجراء فحص بجهاز السبايروميتر.
- اعلام واطلاع الطبيب على نتائج الفحص.
- اعطاء جرعة من موسع القصبات (تبخير الفتولين) واعادة الفحص (بعد ١٥ دقيقة من انتهاء التبخير) بجهاز السبايروميتر وحسب توجيهات الطبيب.
- ارسال المراجع مع الاستمارة وتقرير الجهاز الى الطبيب.
- استرجاع استمارات الرعاية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة من الوحدات الطبية نهاية الدوام الرسمي.
- توثيق النتائج في سجل الجهاز.
- حفظ الاستمارات في اضبارة خاصة.
- اعداد موحد بالاحصائية الفصلية و تسلم الى المنسق (اعداد المفحوصين ، عدد المشخصين بالربو ، عدد المشخصين COPD ، الاحالة ان وجدت.

المنسق :

- فتح ملف المريض وملأ الصفحة الاولى للحالات المشخصة حسب تعليمات الطبيب (الملف هو نفس الملف الطبي للامراض غير الانتقالية).
- أضافة وكبس استمارة الرعاية الاولية للربو في الملف (Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ Asthma) واكمال الحقول

او الاوراق الخاصة بالرعاية الاولية لمرض **COPD.**

(Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ COPD) واكمال الحقول.

- تسجيل الملف في سجل الملفات واعطاءه رقمه تسلسل (اذا كان المركز طب أسرة او يعمل بنظام طب الأسرة يسجل رقم الاسرة ورقم الفرد) ويؤشر التشخيص.
- يتم تزويد الحالات المشخصة ببطاقة مراجعة (يكتب فيها رقم تسلسل ملف المريض ورقم العائلة بالنسبة لمراكز طب الأسرة)
- تسجيل رقم الملف في بطاقة المراجعة.
- ارسال المريض الى الطبيب المعالج مع الملف واستمارة الرعاية الاساسية الامراض التنفسية المزمنة.

- استلام الملف والاستمارات من الطبيب.
- يتم حفظ الملفات الطبية في اضبارة خاصة عند المنسق أما بالنسبة لمراكز صحة الآسرة تحفظ الملفات في الملف العائلي بنفس سياقات العمل المعتمدة.
- التنسيق مع مشغل الجهاز لأعداد الاحصائية الفصلية بالمفحوصين وترسل كل ٣ اشهر رسمياً الى الدائرة.
- تسليم استمارة الرعاية الاساسية الامراض التنفسية المزمنة الى مشغل الجهاز.
- يؤشر في سجل الملفات حقل تنفسية مزمنة ويؤشر طريقة الفحص.
- اعداد احصائية الامراض التنفسية المزمنة ضمن الاحصائية الشهرية للامراض غير الانتقالية.
- اعداد الاحصائية الفصلية للأمراض التنفسية المزمنة ضمن برنامج اكسل احصائية المفحوصين .

ثانيا:- المراكز التي يتوفر PEFM فقط

<u>الوحدة الطبية</u> (الطبيب)

- يتم تحديد المشمولين من قبل الطبيب وحسب ما ورد في استمارة الرعاية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة.
- تملأ الحقول من قبل الطبيب عدا تسلسل الاستمارة .
- يتم اجراء فحص PEFM من قبل الطبيب
- توثيق نتائج الفحص وحسب استمارة الرعاية الاساسية للامراض التنفسية المزمنة
- الايعاز لأعطاء جرعة من موسع القصبات (تبخير الفتولين) واعادة الفحص ١٥ دقيقة بعد انتهاء التبخير .
- تحديد التشخيص النهائي وحسب نتيجة فحص وظائف الرئة للربو فقط .

- الايعاز الى المنسق لفتح ملف المريض (الملف هو نفس الملف الطبي للامراض غير الانتقالية وتضاف وتكبس الاوراق الخاصة بالرعاية الاولية للربو).

(Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ Asthma) واكمال الحقول.

- توثيق نتائج الفحص بجهاز PEFM.
- تصنيف شدة الربو حسب دلائل العمل.
- وصف العلاج وحسب دلائل العمل.
- الاحالة حسب دلائل العمل.
- متابعة الحالات المشخصة
- تحديد موعد المراجعة وحسب الحالة.

- يتم احالة اشتباه الامراض التنفسية الانسدادية المزمنة الى المركز الصحي المرجعي او المستشفى.
- خطة المتابعة الذاتية لمريض الربو وتدريب المريض على استخدامها .
- التأشير في استمارة الرعاية الاساسية للأمراض التنفسية المزمنة .

ملاحظة : في حال وجود تقرير بجهاز سبايروميتر لمريض COPD يتم فتح ملف ايضاً (Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ COPD) .

المنسق :

- جمع استمارات الرعاية الصحية للامراض التنفسية المزمنة من الوحدات الطبية نهاية الدوام الرسمي ومطابقتها مع سجل PEFM.
- حفظ الاستمارات للمفحوصين كافة
- وضع نسخة من الاستمارة في ملف المريض.
- فتح ملف للحالات المشخصة حسب تعليمات الطبيب (الملف هو نفس الملف الطبي للامراض غير الانتقالية وتضاف وتكبس الاوراق الخاصة بالرعاية الاساسية للربو). (Primary Care for Chronic Respiratory Diseases/ Asthma)
- يتم تزويد الحالات المشخصة ببطاقة مراجعة (يكتب فيها اسم المريض والعمر ورقم تسلسل ملف المريض ورقم العائلة بالنسبة لمراكز طب الأسرة)
- يتم حفظ الملفات الطبية في اضبارة خاصة عند المنسق أما بالنسبة لمراكز طب الآسرة تحفظ الملفات في الملف العائلي.
- يؤشر في سجل الملفات حقل تنفسية مزمنة ويؤشر طريقة الفحص.
- اعداد احصائية الامراض التنفسية المزمنة ضمن الاحصائية الشهرية للامراض غير الانتقالية.
- اعداد الاحصائية الفصلية للأمراض التنفسية المزمنة ضمن برنامج اكسل احصائية المفحوصين .

الملاحظات :

- يتم تزويد كل اطباء المركز الصحي المدربين على دلائل العمل وسياقات العمل بنسخة ورقية او الكترونية من استمارة الرعاية الاولية للأمراض التنفسية المزمنة ودلائل العمل .
- تقع مهمة السؤال عن موانع اجراء الفحص بجهاز السبايروميتر على عاتق الطبيب مع ضرورة اطلاع مشغلي الاجهزة عليها.

موانع استخدام جهاز سبايروميتر

Absolute contraindications

- Cardiac surgery/heart attack in the past 1 month
- History of aneurysms: abdominal/thoracic/cerebral
- History of pulmonary embolism 6 months ago
- Suspected or diagnosed case of pulmonary tuberculosis
- Recent thoracic/abdominal/eye surgery 3 weeks
- Presence of facial palsy or deformity /contractures
- Patient unwilling to perform the test.

Relative contraindications

- Smoked tobacco in any form in the last 2hrs
- Consumed tea/coffee/caffeinated drink / alcohol in the past 4hrs
- Heavy meal in past 4 to 5 hour
- Heavy exercise in the past ½ hour
- Bronchodilators: inhaled/oral
- Dementia
- Lower respiratory tract infection in the past 15 days
- Presence of nausea/ vomiting